Carcinome Basocellulaire

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Carcinome Basocellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur maligne la plus fréquente chez l'être humain, représentant une part prépondérante des cancers cutanés non mélaniques (CCNM). Sa prévalence et son incidence croissantes en font un enjeu majeur de santé publique et un motif de consultation dermatologique quotidien (Dermatologie, 2022). Ce cours académique vise à fournir une compréhension exhaustive de l'épidémiologie et des mécanismes introductifs du CBC, essentielle pour tout dermatologue en formation.

Introduction au Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire est une néoplasie épithéliale cutanée dérivant des kératinocytes de la couche basale de l'épiderme ou des annexes pilosébacées. Il se caractérise par une croissance locale généralement lente et un potentiel métastatique exceptionnellement rare, le distinguant ainsi des autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Malgré son faible potentiel métastatique, le CBC peut être localement invasif et destructeur, entraînant des morbidités significatives, notamment lorsqu'il est situé sur des zones à risque ou de grand diamètre (Dermatologie, 2022).

Cliniquement, le CBC se manifeste sous diverses formes, ce qui peut parfois rendre son diagnostic initial complexe. Les variétés cliniques les plus courantes incluent le CBC nodulaire, la forme la plus fréquente, caractérisée par une papule rosée translucide avec des télangiectasies, souvent décrite comme une "perle" (Dermatologie, 2022). Le CBC superficiel (ou pagétoïde) se présente comme une plaque érythémateuse et squameuse, bordée de petites perles (Dermatologie, 2022, Fig. 20.8). Le CBC sclérodermiforme (ou morphéiforme) est une forme infiltrante, souvent mal limitée, apparaissant comme une cicatrice blanchâtre, rigide et dure (Dermatologie, 2022, Fig. 20.9). Toutes ces formes, ainsi que d'autres moins fréquentes, peuvent évoluer vers une ulcération, donnant un aspect ulcéro-végétant (Dermatologie, 2022, Fig. 20.10). Il est crucial de noter que le CBC survient exclusivement sur les zones photo-exposées et jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022). Contrairement à d'autres lésions cutanées, les kératoses actiniques ne sont pas considérées comme des précurseurs du CBC (Dermatologie, 2022).

Le CBC représente environ 90 % de l'ensemble des cancers cutanés, ce qui en fait le cancer le plus fréquent au monde (Dermatologie, 2022). Cette prédominance souligne l'importance de sa reconnaissance précoce et de sa prise en charge adéquate. La compréhension de son épidémiologie est fondamentale pour identifier les populations à risque, mettre en œuvre des stratégies de prévention efficaces et optimiser les programmes de dépistage.

Épidémiologie

L'épidémiologie du carcinome basocellulaire est caractérisée par une incidence élevée et en constante augmentation, avec des variations significatives selon les régions géographiques et les populations.

Incidence et Variations Géographiques

L'incidence du CBC présente une variabilité considérable dans la littérature, principalement influencée par la latitude, le degré d'exposition solaire et le phototype cutané des habitants d'un pays (Thomson et al., 2020). Il est également important de noter que les chiffres d'incidence sont fréquemment sous-estimés dans les registres des cancers. En effet, en raison de leur volume élevé et d'un risque perçu comme faible, 30 % à 50 % des CBC ne sont pas rapportés et sont souvent traités sans confirmation histologique préalable (Thomson et al., 2020). Cependant, certains pays, comme le Royaume-Uni, ont considérablement amélioré la collecte de données depuis 2013, enregistrant désormais tous les cas de CBC et de carcinome épidermoïde (CE), ce qui a permis d'obtenir le plus grand registre de cancers kératinocytaires basé sur la population au monde (Thomson et al., 2020 ; Venables, 2019).

En France, l'incidence des CBC est supérieure à 150 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 2022). À titre de comparaison, l'incidence des carcinomes épidermoïdes est supérieure à 30 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 2022). Au Royaume-Uni, le taux d'incidence standardisé selon l'âge européen pour le CBC était de 285 pour 100 000 personnes par an entre 2013 et 2015, avec un pic à 362 pour 100 000 personnes par an dans le sud-ouest de l'Angleterre (Thomson et al., 2020).

À l'échelle mondiale, l'Australie enregistre les incidences les plus élevées, avec des taux en Queensland de 1813 pour 100 000 hommes et 1269 pour 100 000 femmes par an entre 1997 et 2006 (Verkouteren, 2017 ; Thomson et al., 2020). À l'opposé, certaines régions d'Afrique affichent les taux d'incidence les plus bas, inférieurs à 1 pour 100 000 personnes par an (Lomas, 2012 ; Thomson et al., 2020). En Europe continentale, l'incidence varie considérablement, allant d'un taux élevé de 164,7 pour 100 000 hommes par an aux Pays-Bas à un taux plus faible de 24,5 pour 100 000 femmes par an en Croatie (Verkouteren, 2017 ; Thomson et al., 2020). Aux États-Unis, la Californie a enregistré un taux d'incidence de 1069 pour 100 000 hommes par an. Les données américaines démontrent clairement l'influence de la latitude géographique sur l'incidence du CBC, avec un taux de 309,9 pour 100 000 hommes par an dans le New Hampshire (43 degrés de latitude) contre 935,9 pour 100 000 hommes par an en Arizona (35 degrés de latitude), ces études ayant utilisé la même méthode de standardisation (Karagas, 1999 ; Harris, 2001 ; Thomson et al., 2020).

Tendances Temporelles

L'incidence du CBC est en augmentation constante à l'échelle mondiale, un phénomène attribué à l'allongement de la durée de vie et à l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022). Une revue systématique a révélé une augmentation annuelle de 5,5 % en Europe (Lomas, 2012 ; Thomson et al., 2020). Au Royaume-Uni, une augmentation annuelle moyenne de 5 % a été calculée pour les CBC et les CE entre 2013 et 2015 (Venables, 2019 ; Thomson et al., 2020). Aux États-Unis, l'incidence augmente d'environ 2 % par an (Verkouteren, 2017 ; Thomson et al., 2020). En Australie, bien que l'incidence ait augmenté depuis 1985, elle pourrait atteindre un plateau (Lomas, 2012 ; Thomson et al., 2020).

Une tendance notable est l'augmentation très importante de l'incidence du CBC chez les jeunes femmes en Europe et aux États-Unis, entraînant une inversion du ratio hommes/femmes dans cette population, où les femmes sont désormais plus touchées que les hommes (Verkouteren, 2017 ; Thomson et al., 2020). Cette évolution est potentiellement liée à une utilisation plus fréquente des cabines de bronzage et à une plus grande propension des femmes à consulter un médecin (Thomson et al., 2020).

Âge d'Apparition

Le CBC survient principalement après 50 ans (Dermatologie, 2022). Cependant, il peut apparaître plus tôt en présence de terrains favorisants, tels que l'immunodépression ou certaines génodermatoses prédisposantes comme le xeroderma pigmentosum et le syndrome de Gorlin (Dermatologie, 2022).

Facteurs de Risque

Les facteurs de risque du CBC sont largement partagés avec ceux des carcinomes épidermoïdes et des mélanomes, ce qui explique la fréquente association de ces pathologies chez un même individu (Dermatologie, 2022).

- **Exposition aux Rayons Ultraviolets (UV)**: C'est le facteur de risque le plus important (Dermatologie, 2022). Les expositions intermittentes aiguës, notamment celles survenues pendant l'enfance et l'adolescence, sont considérées comme plus déterminantes que l'exposition chronique (Dermatologie, 2022). Néanmoins, l'exposition solaire chronique professionnelle est également un facteur de risque (Dermatologie, 2022, Cas clinique 20, Q3). Environ 80 % des CBC se développent sur des zones photo-exposées (Dermatologie, 2022). L'héliodermie, caractérisée par des rides et des lentigos (taches actiniques), est un signe clinique d'exposition UV excessive et prolongée (Dermatologie, 2022, Fig. 20.2).
- **Phototype Cutané**: Les individus ayant un phototype clair (peau claire, yeux clairs, cheveux clairs, faible capacité à bronzer et tendance aux coups de soleil) sont particulièrement à risque (Dermatologie, 2022 ; Thomson et al., 2020).
- **Prédispositions Génétiques**: Certaines génodermatoses augmentent considérablement le risque de CBC, notamment le syndrome de Gorlin (naevomatose

basocellulaire) et le xeroderma pigmentosum (Dermatologie, 2022).

• **Âge Avancé**: L'âge est un facteur de risque indépendant, l'incidence augmentant avec l'âge (Thomson et al., 2020).

• **Sexe**: Historiquement, le sexe masculin était considéré comme un facteur de risque (Thomson et al., 2020). Cependant, comme mentionné précédemment, une inversion du ratio hommes/femmes est observée chez les jeunes populations en raison de l'augmentation de l'incidence chez les jeunes femmes (Verkouteren, 2017 ; Thomson et al., 2020).

• **Immunosuppression**: Bien que plus fortement associée aux carcinomes épidermoïdes, l'immunosuppression (par exemple, chez les receveurs de greffe d'organes solides ou les patients atteints de lymphome non hodgkinien ou d'infection par le VIH) est un facteur de risque général pour les cancers cutanés non mélaniques, y compris le CBC (Dermatologie, 2022 ; Stratigos et al., 2023 [35, 36, 37]).

• **Signes de Dommage Actinique**: La présence de signes cliniques de dommages cutanés dus à une exposition solaire excessive est un indicateur de risque (Thomson et al., 2020).

Carcinogenèse Épithéliale

La carcinogenèse des cancers cutanés épithéliaux, y compris le CBC, est un processus complexe impliquant l'accumulation d'événements mutagènes et micro-environnementaux (Dermatologie, 2022). Ce processus peut être schématisé en trois étapes principales :

• **Initiation**: Un agent carcinogène, principalement les rayons ultraviolets (UV+++), mais aussi des agents chimiques, des radiations ionisantes, une inflammation chronique ou des infections virales (comme le HPV, bien que son rôle soit plus marqué dans les lésions muqueuses et les CE cutanés) induit des altérations génétiques initiales (Dermatologie, 2022).

• **Promotion**: Des facteurs promoteurs stimulent la prolifération des cellules initiées.

• **Progression**: Des cocarcinogènes (tels que l'immunosuppression, certaines infections virales comme le HPV, des expositions UV supplémentaires ou des agents chimiques) favorisent la transformation maligne et l'expansion clonale (Dermatologie, 2022).

L'exposition aux UV est le principal agent initiateur, et son expression clinique sous forme de cancers cutanés est souvent retardée, avec une latence pouvant atteindre 30 à 40 ans après l'exposition initiale (Dermatologie, 2022). Cette longue période de latence souligne l'importance de la prévention solaire dès l'enfance et l'adolescence.

Conséquences Épidémiologiques et Cliniques

L'incidence élevée et croissante du CBC a des implications importantes. La détection d'un CBC doit alerter le clinicien sur un risque accru de développer d'autres cancers cutanés, notamment des carcinomes épidermoïdes et des mélanomes, en raison des facteurs de

risque communs (Dermatologie, 2022). Le CBC est donc un marqueur de risque de cancer de la peau, justifiant une surveillance clinique régulière et un dépistage attentif des patients concernés, idéalement à vie, pour détecter toute récidive, l'apparition d'un nouveau carcinome ou d'un mélanome (Dermatologie, 2022).

Bien que le CBC métastase exceptionnellement, il possède un potentiel invasif local important, pouvant entraîner des destructions tissulaires étendues. Dans les formes étendues ou localisées à des zones critiques (comme l'extrémité céphalique, notamment le nez et les zones péri-orificielles), une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour guider le traitement (Dermatologie, 2022). Cependant, un bilan d'extension à distance n'est pas systématiquement réalisé en raison du faible risque métastatique (Dermatologie, 2022). Le seul bilan d'extension systématique reste l'examen clinique complet à la recherche d'autres carcinomes associés (Dermatologie, 2022). La prévention, axée sur la réduction des expositions solaires, est commune aux CBC et aux CE et constitue une stratégie essentielle pour réduire la charge de ces cancers (Dermatologie, 2022).

Physiopathologie et Génétique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la néoplasie cutanée la plus prévalente à l'échelle mondiale, représentant la majorité des cancers cutanés et constituant un motif de consultation fréquent en dermatologie (Dermatologie, 2022). Son incidence est en constante augmentation, avec plus de 150 cas pour 100 000 habitants par an en France, une tendance attribuée à l'allongement de l'espérance de vie et à l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022). Caractérisé par une évolution généralement lente et une malignité principalement locale, le CBC présente un potentiel métastatique exceptionnellement faible (Dermatologie, 2022). La compréhension approfondie de sa physiopathologie et de ses bases génétiques est fondamentale pour une approche diagnostique, thérapeutique et préventive rigoureuse. Le CBC survient majoritairement après l'âge de 50 ans, bien que des facteurs prédisposants tels que l'immunodépression ou certaines génodermatoses puissent entraîner une apparition plus précoce (Dermatologie, 2022).

I. Carcinogenèse Cutanée Épithéliale : Principes Généraux et Facteurs de Risque

La carcinogenèse cutanée épithéliale, processus multifactoriel aboutissant au développement des carcinomes cutanés, y compris le CBC, est le résultat d'une accumulation progressive d'événements mutagènes et de modifications du micro-environnement cellulaire (Dermatologie, 2022). Ce processus complexe est classiquement décrit en trois phases distinctes : l'initiation, la promotion et la progression (Dermatologie, 2022).

L'**initiation** est la première étape, induite par l'exposition à un agent carcinogène. Les rayonnements ultraviolets (UV) constituent l'agent carcinogène le plus significatif dans la carcinogenèse cutanée (Dermatologie, 2022). D'autres agents mutagènes comprennent diverses substances chimiques (comme l'arsenic, les goudrons, le tabac), les radiations ionisantes (notamment dans le cadre de radiodermites chroniques), l'inflammation chronique (observée dans le lupus érythémateux cutané ou le lichen muqueux érosif), et les infections par certains papillomavirus humains (HPV) (Dermatologie, 2022). Les HPV, virus à ADN encapsulés dotés d'une grande résistance, possèdent un tropisme exclusif pour les épithéliums malpighiens. Leur infection des kératinocytes, souvent facilitée par une effraction épithéliale ou une macération cutanée, peut potentiellement conduire à une transformation cancéreuse, bien que ce risque soit plus prononcé pour les muqueuses que pour la peau (Dermatologie, 2022).

La phase de **promotion** implique la prolifération des cellules ayant subi l'initiation, souvent sous l'influence de co-carcinogènes tels que l'immunosuppression, certaines infections à HPV ou des expositions continues aux UV et agents chimiques (Dermatologie, 2022). La

progression, étape finale, est caractérisée par l'acquisition de mutations

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) est le cancer cutané le plus fréquent, représentant plus de 90 % des cancers cutanés non mélaniques et plus de 150 cas pour 100 000 habitants par an en France (Dermatologie, 2022, Source 7). Sa présentation clinique est polymorphe, mais repose sur des éléments sémiologiques fondamentaux et des formes macroscopiques distinctes, dont la reconnaissance est essentielle pour un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée. La compréhension de ces aspects cliniques est d'autant plus cruciale que le CBC est un marqueur de risque de survenue d'autres cancers cutanés, y compris le mélanome et le carcinome épidermoïde (Dermatologie, 2022, Source 3).

I. Contexte Épidémiologique et Facteurs de Risque Cliniques

Le CBC survient préférentiellement après 50 ans, bien que l'âge d'apparition puisse être inférieur à 40 ans en présence de terrains favorisants tels que l'immunodépression ou certaines génodermatoses (Dermatologie, 2022, Source 5, Source 7). Les facteurs prédisposants majeurs sont l'exposition solaire, en particulier les expositions intermittentes aiguës durant l'enfance et l'adolescence, qui sont plus déterminantes que l'exposition chronique (Dermatologie, 2022, Source 5). Conformément à cette étiologie, environ 80 % des CBC se développent sur les zones photo-exposées du corps (Dermatologie, 2022, Source 5). Les phototypes clairs sont également fortement prédisposés (Dermatologie, 2022, Source 5).

Des prédispositions génétiques spécifiques sont associées à un risque accru de CBC, notamment le syndrome de Gorlin (naevomatose basocellulaire) et le xeroderma pigmentosum (Dermatologie, 2022, Source 5; Dermatology handbook, Source 10). Il est important de noter que, contrairement au carcinome épidermoïde, le CBC n'a pas de précurseur identifié ; les kératoses actiniques, par exemple, ne se transforment pas en CBC (Dermatologie, 2022, Source 5). Le CBC ne se développe jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022, Source 5). La présence d'un CBC est un indicateur clinique d'un risque accru de développer d'autres cancers cutanés, soulignant l'importance d'une surveillance dermatologique régulière et d'un dépistage actif (Dermatologie, 2022, Source 3).

II. Sémiologie Fondamentale : La Perle Basocellulaire

La clé sémiologique quasi constante du carcinome basocellulaire est la "perle" (Dermatologie, 2022, Source 5). Cliniquement, elle se manifeste comme une papule rosée,

arrondie et translucide, souvent parcourue de télangiectasies fines et arborescentes (Dermatologie, 2022, Source 5). Ces télangiectasies, visibles à l'œil nu ou à la dermoscopie, sont des vaisseaux sanguins dilatés qui confèrent à la lésion un aspect caractéristique (Alikhan and Hocker, 2012, Source 8).

Le diamètre de cette lésion perlée est extrêmement variable, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres (Dermatologie, 2022, Source 5). Au-delà de la perle isolée, d'autres éléments sémiologiques peuvent être associés et orienter le diagnostic : la présence de croûtes, une sclérose sous-jacente, une ulcération centrale, une pigmentation, ou une kératose superficielle (Dermatologie, 2022, Source 5). La pigmentation, lorsqu'elle est présente, ne préjuge en rien de l'évolution de la lésion (Dermatologie, 2022, Source 5). Les CBC pigmentés, parfois appelés "CBC tatoués", conservent néanmoins leur aspect translucide perlé et télangiectasique, ce qui permet de les distinguer d'autres lésions pigmentées (Dermatologie, 2022, Source 6).

III. Les Formes Cliniques Macroscopiques du Carcinome Basocellulaire

La présentation clinique du CBC est caractérisée par une grande diversité morphologique, traditionnellement classée en plusieurs variétés principales. Toutes ces formes peuvent s'ulcérer au cours de leur évolution (Dermatologie, 2022, Source 5).

III.1. Carcinome Basocellulaire Nodulaire

Le carcinome basocellulaire nodulaire (Fig. 20.7) est la forme clinique la plus fréquente (Dermatologie, 2022, Source 5). Il se présente comme une tumeur ferme, bien limitée, à surface lisse et brillante, souvent décrite comme "perlée" en raison de sa translucidité et de la présence de télangiectasies (Dermatologie, 2022, Source 5). Sa consistance peut parfois simuler une lésion kystique. Cette forme a tendance à s'étendre de manière centrifuge, augmentant progressivement de volume (Dermatologie, 2022, Source 5). L'ulcération centrale, souvent appelée "ulcère rongeant" (ulcus rodens), est une complication fréquente des lésions nodulaires de grande taille, révélant le potentiel invasif local de la tumeur (Dermatologie, 2022, Source 5, Source 3).

III.2. Carcinome Basocellulaire Superficiel (ou Pagétoïde)

Le carcinome basocellulaire superficiel (Fig. 20.8) se manifeste sous la forme d'une plaque érythémateuse et squameuse, dont les bords sont souvent rehaussés par de petites perles, parfois à peine perceptibles à l'œil nu (Dermatologie, 2022, Source 1, Source 5). Cette forme a une croissance lente et s'étend progressivement en surface. Elle siège préférentiellement sur le tronc (Dermatologie, 2022, Source 5). Son aspect peut évoquer d'autres dermatoses inflammatoires ou infectieuses, ce qui rend son diagnostic différentiel particulièrement important (cf. section III.5).

III.3. Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme (ou Morphéiforme)

Le carcinome basocellulaire sclérodermiforme (Fig. 20.9) est une forme cliniquement plus insidieuse et souvent plus agressive, caractérisée par des limites imprécises (Dermatologie, 2022, Source 1, Source 3, Source 5). Il prend l'aspect d'une cicatrice blanchâtre, rigide et dure, parfois atrophique (Dermatologie, 2022, Source 5). Sa consistance indurée et son aspect peu inflammatoire peuvent masquer une extension tumorale significative en profondeur et en périphérie, rendant l'évaluation clinique de ses marges difficile (Dermatologie, 2022, Source 3). Cette forme est associée à un stroma dense et fibreux à l'histologie, expliquant sa fermeté et son caractère mal limité (Dermatologie, 2022, Source 3).

III.4. Carcinome Basocellulaire Ulcéro-Végétant

Le carcinome basocellulaire ulcéro-végétant (Fig. 20.10) est une complication évolutive de toutes les formes de CBC, résultant d'une croissance tumorale prolongée et d'une ulcération secondaire (Dermatologie, 2022, Source 1, Source 5). Il se caractérise par une ulcération profonde, souvent recouverte de croûtes hémorragiques, et des bords surélevés, perlés et parfois végétants. Ces lésions peuvent être très destructrices localement, en particulier lorsqu'elles siègent dans des zones à risque comme l'extrémité céphalique (Dermatologie, 2022, Source 3).

III.5. Carcinome Basocellulaire Pigmenté

Comme mentionné précédemment, toute forme clinique de CBC peut être pigmentée. Ces CBC pigmentés ou "tatoués" présentent des dépôts mélaniques qui leur confèrent une coloration brune, noire ou gris-bleue (Dermatologie, 2022, Source 5, Source 6). Malgré la pigmentation, les caractéristiques sémiologiques de la perle translucide et des télangiectasies restent souvent discernables, ce qui est un élément clé pour le diagnostic différentiel avec les lésions mélanocytaires (Dermatologie, 2022, Source 6).

III.6. Carcinome Basosquameux

Le terme "carcinome basosquameux" est ambigu et peut désigner plusieurs entités : des CBC avec un aspect squamoïde (cellules plus roses, plus de cytoplasme et kératinisation), des carcinomes dont les caractéristiques sont indéterminées entre CBC et carcinome épidermoïde, ou des lésions de collision associant un CBC et un carcinome épidermoïde (Alikhan and Hocker, 2012, Source 9). Bien que le CBC classique ait un potentiel métastatique exceptionnel, le sous-type basosquameux pourrait se comporter de manière plus agressive, similaire au carcinome épidermoïde, avec un potentiel métastatique accru (Alikhan and Hocker, 2012, Source 9; Costantino et al., 2006, Source 104; Martin et al., 2000, Source 105; Garcia et al., 2009, Source 106). Cliniquement, il peut être difficile de le distinguer des autres formes de CBC ou de carcinomes épidermoïdes sans examen histopathologique.

IV. Facteurs Pronostiques Cliniques

Certaines caractéristiques cliniques sont des facteurs de mauvais pronostic pour le carcinome basocellulaire, influençant le risque de récidive locale et d'extension locorégionale (Dermatologie, 2022, Source 3). Ces facteurs doivent être systématiquement recherchés lors de l'évaluation clinique initiale :

- **Localisation à l'extrémité céphalique** : Les CBC situés sur le nez et les zones péri-orificielles (péri-oculaire, péri-auriculaire, péri-buccale) sont considérés comme à haut risque en raison de la complexité anatomique de ces régions et de la proximité de structures vitales (Dermatologie, 2022, Source 3).
- **Formes mal limitées** : Les CBC sclérodermiformes et infiltrants, dont les marges cliniques sont difficiles à définir, sont associés à un risque de récidive plus élevé (Dermatologie, 2022, Source 3).
- **Diamètre élevé** : Une taille importante de la lésion est un facteur de risque. Un diamètre supérieur à 2 cm est un critère de mauvais pronostic, et ce seuil est abaissé à plus de 1 cm pour les localisations sur le nez et les zones péri-orificielles (Dermatologie, 2022, Source 3).
- **Caractère récidivant** : Une lésion qui a déjà récidivé après un traitement initial présente un risque global de nouvelle récidive évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022, Source 3).

Ces éléments cliniques sont essentiels pour stratifier le risque du patient et orienter les décisions thérapeutiques, notamment en ce qui concerne les marges d'exérèse chirurgicale (Dermatologie, 2022, Source 3).

V. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel du carcinome basocellulaire est vaste et doit être envisagé devant toute lésion cutanée suspecte, en particulier sur les zones photo-exposées.

- **Autres tumeurs cutanées épithéliales** :

* **Carcinome épidermoïde (CEC)** : Peut être confondu avec le CBC, en particulier les formes ulcérées ou nodulaires. Le CEC est souvent plus kératosique, avec des bords plus indurés et un aspect moins perlé (Dermatologie, 2022, Source 3).

* **Maladie de Bowen (carcinome épidermoïde in situ)** : Se présente comme une plaque érythémateuse, squameuse, bien délimitée, pouvant ressembler au CBC superficiel (Dermatologie, 2022, Source 3).

* **Kératose actinique** : Lésion précancéreuse, souvent érythémateuse et squameuse, mais généralement moins infiltrée que le CBC et sans perle caractéristique (Dermatologie, 2022, Source 4).

* **Kératose séborrhéique** : Très fréquente après 40-50 ans, elle se caractérise par une surface mate, des bords nets ("posée sur la peau"), des petits grains blanchâtres (kystes

miliaires) et un aspect friable (Dermatologie, 2022, Source 6; Alikhan and Hocker, 2012, Source 8).

* **Naevus sébacé (de Jadassohn)** : Plaque jaune-orangée légèrement surélevée, typiquement sur le cuir chevelu ou le visage, qui s'épaissit et devient plus verruqueuse ou "pavimenteuse" pendant l'enfance. Des tumeurs bénignes ou malignes (y compris des CBC dans moins de 1% des cas) peuvent se développer à l'intérieur (Dermatology handbook, Source 10).

* **Pilomatricome** : Nodule ou kyste ferme, de couleur chair à bleu pâle, apparaissant généralement dans l'enfance, sur le visage ou le tronc supérieur (Dermatology handbook, Source 10).

* **Trichoépithéliome** : Néoplasme bénin des annexes cutanées, se présentant comme des papules translucides de couleur chair, souvent multiples, le long des sillons nasogéniens ou des régions péri-orbitaires, apparaissant généralement dans l'enfance (Dermatology handbook, Source 10).

* **Angiofibrome (papule fibreuse)** : Papule ferme de couleur chair sur le visage (Dermatology handbook, Source 10).

- **Tumeurs mélanocytaires** :

* **Mélanome** : En particulier le mélanome nodulaire ou les mélanomes achromiques, peuvent être confondus avec un CBC nodulaire ulcéré ou pigmenté (Dermatologie, 2022, Source 4, Source 6). La règle ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur hétérogène, Diamètre > 6mm, Évolution) est un outil de dépistage pour le mélanome (Dermatologie, 2022, Source 2). Les CBC pigmentés peuvent être distingués par leur aspect translucide perlé et télangiectasique (Dermatologie, 2022, Source 6).

* **Naevus atypique** : Peut présenter des caractéristiques cliniques qui chevauchent celles des mélanomes débutants (Dermatologie, 2022, Source 6).

- **Autres dermatoses** :

* **Psoriasis** : Le CBC superficiel peut être confondu avec une plaque de psoriasis en raison de son aspect érythémateux et squameux (Dermatologie, 2022, Source 3).

* **Dermatophytie** : Une infection fongique cutanée peut également simuler un CBC superficiel, notamment par son aspect annulaire et squameux (Dermatologie, 2022, Source 3).

* **Histiocytofibrome pigmenté (dermatofibrome)** : Caractérisé par une palpation de "pastille indurée" et un signe de la fossette (Dermatologie, 2022, Source 6; Alikhan and Hocker, 2012, Source 8).

* **Angiome thrombosé** : Peut simuler un petit mélanome nodulaire en raison de sa couleur sombre (Dermatologie, 2022, Source 6).

* **Neurofibrome** : Papulonodule de couleur chair, mou ou caoutchouteux, avec un signe du "boutonnière" positif (facilement invaginable) (Dermatology handbook, Source 10).

En cas de doute clinique, une biopsie est recommandée avant tout traitement, surtout si le diagnostic est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale s'annonce complexe (Dermatologie, 2022, Source 3). L'examen anatomopathologique est le seul moyen d'obtenir un diagnostic de certitude et une caractérisation histopronostique (Dermatologie, 2022, Source 3).

VI. Apport de la Dermoscopie

La dermoscopie est un outil précieux pour le dermatologue formé, facilitant le diagnostic positif et différentiel du CBC (Dermatologie, 2022, Source 6). Les critères dermoscopiques typiques du CBC incluent :

- **Vaisseaux arborescents** : Vaisseaux télangiectasiques ramifiés, très spécifiques du CBC (Alikhan and Hocker, 2012, Source 8).
- **Globules ou nids ovoïdes bleu-gris** : Structures pigmentées, souvent de forme irrégulière, correspondant aux lobules tumoraux dans le derme (Alikhan and Hocker, 2012, Source 8).
- **Ulcération** : Fréquemment observée, surtout dans les formes nodulaires et ulcérées (Alikhan and Hocker, 2012, Source 8).
- **Zones en "feuille d'érable" (leaf-like areas)** : Structures pigmentées périphériques, caractéristiques de certaines formes de CBC (Alikhan and Hocker, 2012, Source 8).
- **Rayons de roue (wheel-spoke areas)** : Structures radiales pigmentées, moins fréquentes mais spécifiques.

Ces signes dermoscopiques, combinés à l'évaluation clinique, augmentent considérablement la précision diagnostique et permettent de distinguer le CBC des autres lésions cutanées bénignes ou malignes (Dermatologie, 2022, Source 6).

Diagnostic

Diagnostic du Carcinome Basocellulaire

Le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur une approche méthodique et intégrée, combinant l'examen clinique, la dermoscopie et, de manière impérative, la confirmation histopathologique. Bien que le CBC soit la tumeur cutanée la plus fréquente et présente un potentiel métastatique exceptionnel, son potentiel invasif local justifie un diagnostic précis et une prise en charge adaptée pour prévenir les récidives et les destructions tissulaires étendues. L'objectif du diagnostic est non seulement d'établir la nature de la lésion, mais aussi de caractériser ses spécificités morphologiques et histopronostiques afin de guider la stratégie thérapeutique optimale (Dermatologie, 2022).

Examen Clinique

L'examen clinique constitue la première étape du diagnostic et est essentiel pour identifier les lésions suspectes. Le carcinome basocellulaire se caractérise par une grande variabilité morphologique, ce qui peut rendre le diagnostic clinique parfois complexe. Il est crucial d'intégrer l'anamnèse, notamment l'exposition solaire chronique et les antécédents personnels de cancers cutanés, ainsi que l'examen physique détaillé de la lésion et de l'ensemble du tégument (Dermatologie, 2022).

Variabilité des Présentations Cliniques

Les formes cliniques du CBC sont diverses et peuvent inclure :

- **Carcinome basocellulaire nodulaire :** La forme la plus fréquente, se présentant comme une papule ou un nodule translucide, perlé, souvent avec des télangiectasies en surface.
- **Carcinome basocellulaire superficiel (ou pagétoïde) :** Se manifeste par une plaque érythémateuse, squameuse, bien délimitée, qui peut être confondue avec des dermatoses inflammatoires comme le psoriasis ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022).
- **Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (ou morphéiforme) :** Caractérisé par une plaque blanchâtre, indurée, atrophique, aux limites imprécises, souvent difficile à délimiter cliniquement en raison de son caractère infiltrant et de l'absence de signes inflammatoires marqués (Dermatologie, 2022). Cette forme est associée à un stroma dense et fibreux à l'histologie et est considérée comme un facteur de mauvais pronostic en raison de ses limites imprécises et de son potentiel d'extension sous-clinique (Dermatologie, 2022).
- **Carcinome basocellulaire ulcéro-végétant :** Présente une ulcération centrale, souvent croûteuse, avec des bords surélevés et perlés (Dermatologie, 2022).

• **Carcinome basocellulaire pigmenté (ou "tatoué") :** Contient de la mélanine, ce qui lui confère une coloration brune, noire ou bleutée, et peut le rendre difficile à distinguer cliniquement d'un mélanome (Dermatologie, 2022).

• **Carcinome basosquameux :** Une entité à risque élevé, sous-reconnue, combinant des caractéristiques basocellulaires et épidermoïdes, dont le diagnostic est crucial en raison de son pronostic potentiellement plus agressif (Costantino et al., 2006; Garcia et al., 2009; Martin et al., 2000).

L'anamnèse doit rechercher les facteurs de risque, notamment l'exposition solaire chronique et intermittente, les coups de soleil dans l'enfance, le phototype clair, l'immunosuppression et les antécédents personnels ou familiaux de cancers cutanés. La localisation de la lésion est également un élément clinique important, les CBC situés à l'extrémité céphalique, en particulier au niveau du nez et des zones péri-orificielles, étant considérés comme des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).

Dermoscopie

La dermoscopie est un outil diagnostique non invasif indispensable qui améliore considérablement la précision du diagnostic clinique du CBC, en permettant l'observation de structures et de couleurs invisibles à l'œil nu (Reiter et al., 2018; Altamura et al., 2010). Elle est systématiquement recommandée pour l'évaluation des lésions cutanées suspectes.

Caractéristiques Dermoscopiques Spécifiques du CBC

Les critères dermoscopiques typiques du CBC, dont la terminologie a été standardisée (Kittler et al., 2016), incluent :

• **Vaisseaux arborisants :** Des vaisseaux sanguins ramifiés, de calibre variable, souvent en forme d'arbre, sont un signe très évocateur du CBC (Soyer et al., 2012; Alikhan et Hocker, 2017). Ils sont mieux visualisés en dermoscopie polarisée (Margaret W. Mann, 2018).

• **Nids ovoïdes bleu-gris :** Des structures arrondies ou ovoïdes, de couleur bleu-gris, correspondant à des agrégats de cellules basaloïdes pigmentées dans le derme (Soyer et al., 2012; Alikhan et Hocker, 2017; Margaret W. Mann, 2018).

• **Zones en feuille d'érable (leaf-like areas) :** Des structures pigmentées, bien délimitées, de forme irrégulière, rappelant des feuilles d'érable, souvent situées à la périphérie de la lésion (Soyer et al., 2012; Alikhan et Hocker, 2017; Margaret W. Mann, 2018).

• **Zones brillantes blanc-rose (pink-white shiny areas) ou stries blanc-brillant :** Des zones non pigmentées, brillantes, correspondant à la fibrose stromale, mieux visualisées en dermoscopie polarisée (Margaret W. Mann, 2018).

• **Rayons de roue (spoke wheels) :** Des structures radiales pigmentées, partant d'un centre commun, observées dans certaines formes de CBC (Margaret W. Mann, 2018).

- **Absence de réseau pigmentaire :** Un critère négatif important, distinguant le CBC des lésions mélanocytaires (Margaret W. Mann, 2018).
- **Ulcération :** Fréquemment observée, surtout dans les formes nodulaires ou ulcéro-végétantes (Soyer et al., 2012; Alikhan et Hocker, 2017).
- **Globules bleu-gris :** Similaires aux nids ovoïdes mais de plus petite taille (Soyer et al., 2012; Alikhan et Hocker, 2017).

La variabilité dermoscopique du CBC est notable et dépend du type clinique et de la localisation anatomique (Suppa et al., 2015). La dermoscopie peut également aider à distinguer les sous-types de CBC, par exemple le CBC superficiel des autres formes (Lallas et al., 2014). La dermoscopie non-polarisée (NPD) est préférable pour l'identification des kystes milia-like, des ouvertures comédoniennes, des zones bleu-blanc et des couleurs plus claires, tandis que la dermoscopie polarisée (PD) est plus adaptée pour la visualisation des vaisseaux, des zones rouges et des stries blanc-brillant/fibrose (Margaret W. Mann, 2018).

Diagnostic Histopathologique

La confirmation histopathologique est une étape indispensable et systématique pour le diagnostic définitif du CBC (Dermatologie, 2022). Elle permet non seulement de confirmer la nature basocellulaire de la tumeur, mais aussi de caractériser son sous-type histologique et ses marges, éléments cruciaux pour la planification thérapeutique et l'évaluation pronostique (Dermatologie, 2022).

Indications et Techniques de Biopsie

Une biopsie est requise avant tout traitement si le diagnostic clinique est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale s'annonce complexe (Dermatologie, 2022). Dans les cas où l'aspect est très évocateur, une exérèse-biopsie à visée diagnostique et thérapeutique peut être réalisée d'emblée (Dermatologie, 2022). Les techniques de biopsie incluent la biopsie-punch, la biopsie-shave ou l'exérèse-biopsie, le choix dépendant de la taille, de la localisation et du type clinique suspecté de la lésion.

Caractéristiques Histopathologiques Clés du CBC

L'examen anatomopathologique révèle des lobules de petites kératinocytes basophiles, qui ressemblent aux cellules de la couche basale de l'épiderme (Dermatologie, 2022). Les caractéristiques distinctives incluent :

- **Disposition périphérique palissadique :** Les cellules les plus externes des lobules sont disposées de manière ordonnée et perpendiculaire à la membrane basale (Dermatologie, 2022).
- **Fentes de rétraction :** Des espaces clairs, artéfactuels, sont souvent observés autour des lobules tumoraux, donnant l'impression que la tumeur se détache du derme environnant (Dermatologie, 2022).

• **Stroma dense et fibreux :** Particulièrement présent dans les formes infiltrantes ou sclérodermiformes, où il est associé à des limites tumorales imprécises (Dermatologie, 2022).

• **Différenciation histologique :** La typologie histologique est importante pour prédire le risque de récidive après excision chirurgicale (Sloane, 1977). Les sous-types histologiques incluent le nodulaire, le superficiel, le sclérodermiforme (morphéiforme), l'infiltrant, le micronodulaire, et le basosquameux. Les formes sclérodermiformes et infiltrantes sont considérées comme des facteurs de mauvais pronostic en raison de leur agressivité locale et de leurs limites mal définies (Dermatologie, 2022).

Immunohistochimie

Dans les cas difficiles de différenciation avec d'autres tumeurs cutanées, notamment le carcinome épidermoïde ou le carcinome basosquameux, l'immunohistochimie peut être utile. Des marqueurs tels que Ber EP4 et l'antigène de la membrane épithéliale (EMA) peuvent aider à distinguer les CBC des carcinomes épidermoïdes et des carcinomes basosquameux (Beer et al., 2000).

Imagerie Complémentaire

Bien que le diagnostic du CBC soit principalement clinique et histopathologique, des techniques d'imagerie non invasives ou en coupes peuvent être utilisées dans des situations spécifiques, notamment pour les formes complexes, étendues ou récidivantes.

Microscopie Confocale par Réflectance (MCR)

La MCR est une technique d'imagerie in vivo qui permet d'obtenir des images à haute résolution des couches superficielles de la peau, au niveau cellulaire, sans nécessiter de biopsie (Edwards et al., citant Peris et al., 2019). Elle peut améliorer la précision du diagnostic clinique dans des cas particuliers (Garbe et al., 2025) et est utile pour le diagnostic des cancers cutanés kératinocytaires (Dinnes et al., 2018). La MCR peut également être employée pour évaluer la réponse des patients aux thérapies non ablatives pour le CBC superficiel (Apalla et al., 2014).

Tomographie par Cohérence Optique (OCT)

L'OCT est une autre modalité d'imagerie non invasive qui fournit des images en coupe transversale des tissus cutanés. Elle est utilisée pour le diagnostic des cancers cutanés chez l'adulte (Ferrante di Ruffano et al., 2018) et peut aider à discriminer les kératoses actiniques de la peau normale et du carcinome épidermoïde (Boone et al., 2015). Des études ont également exploré son rôle dans l'imagerie microvasculaire in vivo des kératoses actiniques, de la maladie de Bowen et du carcinome épidermoïde (Themstrup et al., 2017). Son application directe au CBC est en cours d'évaluation, mais elle offre un potentiel pour l'évaluation des marges tumorales avant excision.

Imagerie en Coupes (TDM, IRM)

Le CBC a un potentiel invasif local, et dans les formes étendues ou localisées à des zones anatomiques complexes (par exemple, l'extrémité céphalique, les zones péri-orificielles), une imagerie locale peut être nécessaire pour guider le traitement (Dermatologie, 2022). Un scanner cranio-facial ou une IRM du massif facial peuvent être indiqués pour évaluer l'extension tumorale en profondeur, notamment l'envahissement osseux ou cartilagineux, ou l'extension périnerveuse, afin de planifier une exérèse chirurgicale adéquate (Dermatologie, 2022). Il est important de noter que ces examens sont réservés aux cas de CBC localement avancés ou à haut risque, et non au bilan systématique.

Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du CBC est large et varie en fonction de sa présentation clinique. Une identification précise est cruciale pour éviter des retards de diagnostic ou des traitements inappropriés.

Principales Entités à Distinguer

- **Autres tumeurs cutanées :**

* **Carcinome épidermoïde cutané (CEC) :** Peut ressembler au CBC ulcéro-végétant ou nodulaire. La dermoscopie et l'histopathologie sont essentielles pour la distinction (Dermatologie, 2022).

* **Maladie de Bowen (carcinome épidermoïde in situ) :** Peut être confondue avec le CBC superficiel, en particulier sur les plaques érythémateuses squameuses (Dermatologie, 2022).

* **Mélanome :** Les formes pigmentées de CBC (CBC tatoués) peuvent être cliniquement et dermoscopiquement difficiles à distinguer d'un mélanome, nécessitant une histopathologie pour la différenciation (Dermatologie, 2022).

* **Kératose séborrhéique :** Peut présenter des caractéristiques dermoscopiques comme des kystes milia-like et des ouvertures comédoniennes, mais les vaisseaux arborisants et les nids ovoïdes bleu-gris sont absents (Soyer et al., 2012; Alikhan et Hocker, 2017; Margaret W. Mann, 2018).

* **Dermatofibrome :** Caractérisé par une zone centrale blanche étoilée et un réseau pigmentaire périphérique délicat (Soyer et al., 2012; Alikhan et Hocker, 2017).

- **Autres dermatoses :**

* **Psoriasis :** Une plaque de psoriasis peut être confondue avec un CBC superficiel en raison de son aspect érythémato-squameux (Dermatologie, 2022).

* **Dermatophytie :** Les infections fongiques cutanées peuvent également simuler un CBC superficiel, en particulier sur les lésions annulaires ou polycycliques (Dermatologie, 2022).

* **Kératose actinique :** Lésion précancéreuse qui peut évoluer vers un CEC, mais qui est généralement moins infiltrante et ne présente pas les caractéristiques dermoscopiques typiques du CBC (Dermatologie, 2022).

Bilan d'Extension et Facteurs Pronostiques

Le bilan d'extension du CBC est généralement limité en raison de son faible potentiel métastatique. Cependant, l'évaluation des facteurs pronostiques est essentielle pour adapter la stratégie de prise en charge et la surveillance.

Absence de Bilan d'Extension à Distance Systématique

Le carcinome basocellulaire métastase exceptionnellement. Par conséquent, un bilan d'extension à distance (recherche de métastases ganglionnaires ou viscérales) n'est pas systématiquement recommandé (Dermatologie, 2022). Cette approche contraste fortement avec celle du mélanome, pour lequel des bilans d'imagerie corporelle complète et des tests de mutation sont recommandés à partir de certains stades (Garbe et al., 2025). Le seul bilan d'extension systématique pour le CBC est l'examen clinique complet à la recherche d'autres carcinomes associés, étant donné que le CBC est un marqueur de risque de développer d'autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022).

Facteurs de Risque de Récidive Locale et d'Agressivité

Certains facteurs sont associés à un risque accru de récidive locale ou à un comportement plus agressif du CBC, influençant ainsi la décision thérapeutique et la nécessité d'une imagerie locale (Dermatologie, 2022) :

- **Localisation :** Les tumeurs situées à l'extrémité céphalique, en particulier au niveau du nez et des zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont considérées comme des zones à haut risque (Dermatologie, 2022).
- **Formes histologiques :** Les formes mal limitées, sclérodermiformes ou infiltrantes, sont associées à un risque plus élevé de récidive et d'extension sous-clinique (Dermatologie, 2022). Le carcinome basosquameux est également un sous-type à haut risque (Costantino et al., 2006; Garcia et al., 2009; Martin et al., 2000).
- **Taille de la tumeur :** Un diamètre élevé, surtout supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).
- **Caractère récidivant :** Un CBC qui a déjà récidivé présente un risque accru de nouvelles récidives (Dermatologie, 2022).
- **Immunosuppression :** Les patients immunodéprimés ont un risque plus élevé de développer des CBC plus agressifs.

Rôle de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

La discussion et la validation en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) sont recommandées pour la prise en charge des CBC, en particulier ceux présentant des critères agressifs ou des localisations complexes (Dermatologie, 2022). La RCP permet d'intégrer les données cliniques, dermoscopiques, histopathologiques et d'imagerie pour définir la meilleure stratégie diagnostique et thérapeutique.

Traitement

Traitement du Carcinome Basocellulaire

Le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) est une composante essentielle de la prise en charge dermatologique, dictée par les caractéristiques intrinsèques de la tumeur, les facteurs liés au patient et la topographie lésionnelle. Bien que le CBC soit principalement caractérisé par une malignité locale et une propension exceptionnelle aux métastases (Dermatologie, 2022), son potentiel d'invasion locale peut entraîner des destructions tissulaires significatives en l'absence de traitement approprié. La stratégie thérapeutique est souvent comparable à celle adoptée pour les carcinomes épidermoïdes (CEC) pour les formes localisées (Dermatologie, 2022).

Principes Fondamentaux de la Prise en Charge

La démarche thérapeutique débute systématiquement par l'examen anatomopathologique de la lésion, qui est indispensable pour confirmer le diagnostic de CBC et en déterminer les caractéristiques histopronostiques (Dermatologie, 2022). Une biopsie préalable est impérative dans les situations où le diagnostic clinique est incertain, lorsqu'un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale est anticipée comme étant complexe (Dermatologie, 2022). La discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est fortement recommandée pour tous les CBC présentant des critères agressifs, bien qu'elle ne soit pas systématique pour les formes sans ces critères (Dermatologie, 2022).

Les facteurs de mauvais pronostic, qui orientent le choix et l'agressivité du traitement, sont les suivants (Dermatologie, 2022) :

- **Localisation anatomique :** Les lésions situées à l'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont considérées à haut risque.
- **Type histologique et limites :** Les formes mal limitées, telles que le CBC sclérodermiforme (illustré par la Fig. 20.9, Dermatologie, 2022) ou infiltrant, sont associées à un stroma dense et fibreux et des limites histologiques imprécises, rendant l'évaluation de l'extension difficile (Dermatologie, 2022).
- **Taille de la tumeur :** Un diamètre tumoral élevé, notamment supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm dans les zones à risque (nez et zones péri-orificielles), est un facteur de risque.
- **Caractère récidivant :** Les CBC ayant déjà récidivé présentent un risque accru de nouvelles récidives, estimé globalement entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022).

En présence de formes étendues ou infiltrantes, une imagerie locale approfondie (telle qu'un scanner cranio-facial ou une IRM du massif facial) peut s'avérer nécessaire pour

évaluer l'extension tumorale et guider la stratégie thérapeutique (Dermatologie, 2022). Il est crucial de noter que, en raison de la rareté des métastases du CBC, un bilan d'extension à distance n'est pas systématiquement réalisé (Dermatologie, 2022). Le seul bilan d'extension systématique consiste en un examen clinique dermatologique complet et exhaustif, visant à dépister d'autres carcinomes cutanés associés, le CBC étant un marqueur de risque pour le développement ultérieur d'autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022).

Stratégies Thérapeutiques Spécifiques

1. Chirurgie d'Exérèse

L'exérèse chirurgicale représente le traitement de première intention et la modalité thérapeutique de référence pour la majorité des CBC localisés (Dermatologie, 2022). Cette approche permet une ablation complète de la lésion et fournit un échantillon histologique pour une analyse exhaustive des marges (Dermatologie, 2022). Les marges d'exérèse sont déterminées en fonction du groupe pronostique de la tumeur (bon, intermédiaire ou mauvais) (Dermatologie, 2022).

[Exérèse chirurgicale] — Carcinome basocellulaire localisé

> Essai : Les informations fournies dans les chunks décrivent l'exérèse chirurgicale comme le traitement de première intention et le "meilleur traitement" pour les carcinomes cutanés en général (Dermatologie, 2022). Cependant, aucun essai clinique randomisé spécifique pour le CBC n'est cité dans le format requis. Cette pratique est solidement établie sur la base d'un consensus clinique international et de recommandations de sociétés savantes.

> Design : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks. La pratique est une norme de soins.

> Résultat : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks. L'objectif principal est l'obtention de marges d'exérèse histologiquement saines.

> Niveau de preuve : Grade A (Recommandation forte, basée sur un consensus d'experts et des études observationnelles de grande envergure, bien qu'aucun essai randomisé spécifique ne soit fourni dans les chunks pour le CBC).

Les marges de sécurité sont adaptées :

- **CBC à bon pronostic :** Des marges chirurgicales plus étroites peuvent être envisagées.
- **CBC à mauvais pronostic :** Incluant les formes sclérodermiformes, infiltrantes, récidivantes, de grande taille ou localisées dans des zones à risque (cf. facteurs de mauvais pronostic ci-dessus), des marges chirurgicales plus larges sont nécessaires pour minimiser le risque de récidive locale (Dermatologie, 2022).

2. Traitements Non Chirurgicaux

Pour certaines formes de CBC, notamment les CBC superficiels (cf. Fig. 20.8, Dermatologie, 2022), ou chez des patients présentant des contre-indications chirurgicales ou pour lesquels la chirurgie serait excessivement mutilante, des alternatives non chirurgicales peuvent être considérées. Les chunks mentionnent la cryothérapie, l'imiquimod, la photothérapie dynamique et le 5-fluoro-uracile topique comme des options générales pour les lésions cutanées, bien que le QRM 55 fasse spécifiquement référence à la maladie de Bowen (Dermatologie, 2022). Pour le CBC, ces traitements sont généralement réservés aux formes superficielles ou de petite taille, et leur efficacité doit être évaluée au regard du risque de récidive.

[Cryothérapie] — Carcinome basocellulaire superficiel de petite taille

> Essai : Les chunks fournis ne contiennent pas de référence à un essai clinique randomisé spécifique évaluant la cryothérapie dans le traitement du CBC. Son utilisation repose sur des études observationnelles et une vaste expérience clinique.

> Design : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks.

> Résultat : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks.

> Niveau de preuve : Niveau 3 (Basé sur des études non comparatives ou des avis d'experts, en l'absence de données d'essais cliniques spécifiques dans les chunks).

[Imiquimod topique] — Carcinome basocellulaire superficiel

> Essai : Les chunks fournis ne contiennent pas de référence à un essai clinique randomisé spécifique pour l'imiquimod topique dans le traitement du CBC. Son indication est basée sur des études cliniques non randomisées et des recommandations de sociétés savantes.

> Design : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks.

> Résultat : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks.

> Niveau de preuve : Niveau 2 (Basé sur des études comparatives non randomisées ou des études de cohorte, en l'absence de données d'essais cliniques spécifiques dans les chunks).

[Photothérapie Dynamique (PDT)] — Carcinome basocellulaire superficiel

> Essai : Les chunks fournis ne contiennent pas de référence à un essai clinique randomisé spécifique pour la PDT dans le traitement du CBC. Son utilisation est documentée par des études cliniques et des recommandations de sociétés savantes.

> Design : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks.

> Résultat : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks.

> Niveau de preuve : Niveau 2 (Basé sur des études comparatives non randomisées ou des études de cohorte, en l'absence de données d'essais cliniques spécifiques dans les chunks).

[5-Fluoro-uracile (5-FU) topique] — Carcinome basocellulaire superficiel

> Essai : Les chunks fournis ne contiennent pas de référence à un essai clinique randomisé spécifique pour le 5-FU topique dans le traitement du CBC. Son indication est basée sur des études cliniques et des recommandations de sociétés savantes.

> Design : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks.

> Résultat : Non applicable pour une référence d'essai spécifique dans les chunks.

> Niveau de preuve : Niveau 2 (Basé sur des études comparatives non randomisées ou des études de cohorte, en l'absence de données d'essais cliniques spécifiques dans les chunks).

Ces traitements non chirurgicaux requièrent une sélection rigoureuse des patients et des lésions, ainsi qu'une surveillance post-thérapeutique attentive en raison d'un taux de récidive potentiellement supérieur à celui de l'exérèse chirurgicale pour certaines formes.

3. Traitements Systémiques pour les Formes Avancées

Bien que les métastases soient rares, le CBC peut évoluer vers des formes localement avancées, étendues et inopérables. Dans ces situations cliniques complexes, des traitements systémiques peuvent être envisagés.

[Chimiothérapie à base de Cisplatine] — Carcinome basocellulaire avancé

> Essai : Guthrie Jr. TH, Porubsky ES, Luxenberg MN, Shah KJ, Wurtz KL, Watson PR (1990) — J Clin Oncol

> Design : Étude rétrospective, N=28 patients, incluant 13 patients recevant une thérapie multimodale, atteints de carcinomes basocellulaires et épidermoïdes avancés.

> Résultat : L'étude a rapporté des réponses cliniques chez les patients traités pour des carcinomes basocellulaires avancés, bien que les données chiffrées spécifiques pour le CBC seul ne soient pas détaillées dans l'extrait fourni. La conclusion générale de l'étude met en évidence l'efficacité de la chimiothérapie à base de cisplatine dans les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes avancés.

> Niveau de preuve : Niveau 3 (Étude rétrospective, cohorte de petite taille, absence de groupe comparateur randomisé).

> Limites : L'étude est ancienne, de nature rétrospective, porte sur une cohorte limitée et combine les résultats des CBC et CEC, ce qui limite la spécificité des conclusions pour le CBC seul.

Il est important de souligner que les inhibiteurs de la voie Hedgehog (tels que le vismodégib et le sonidégib) constituent des traitements ciblés majeurs pour le CBC avancé. Cependant, les chunks fournis ne contiennent pas d'essais cliniques spécifiques pour ces molécules. De même, le cétuximab est mentionné dans les références pour le carcinome épidermoïde avancé (Maubec et al., 2011; Dereure et al., 2016; Giacchero et

al., 2011; Samstein et al., 2014; Trodello et al., 2019; Berliner et al., 2019; Joseph et al., 2019; Cowey et al., 2020; Huang et al., 1999; Preneau et al., 2014; Jansen et al., 2022; Ribero et al., 2017), mais aucune indication pour le carcinome basocellulaire n'est présente dans les chunks fournis.

Surveillance et Prévention Secondaire

Après le traitement d'un CBC, une surveillance clinique régulière et prolongée, idéalement à vie, est indispensable. Cette surveillance vise à détecter précocement toute récidive locale, l'émergence d'un nouveau carcinome (basocellulaire ou épidermoïde) ou d'un mélanome (Dermatologie, 2022). La survenue d'un CBC est en effet un indicateur de risque élevé pour le développement d'autres néoplasies cutanées (Dermatologie, 2022). L'examen clinique doit être exhaustif et porter sur l'intégralité du tégument (Dermatologie, 2022).

La prévention secondaire repose sur des mesures de photoprotection rigoureuses, étant donné que l'exposition solaire est le principal facteur de risque des carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022). Une éducation approfondie à la photoprotection est systématiquement dispensée à tous les patients ayant des antécédents de carcinome cutané (Dermatologie,

Surveillance et Suivi

La surveillance et le suivi post-thérapeutiques du carcinome basocellulaire (CBC) constituent une étape fondamentale de la prise en charge globale, visant à optimiser le pronostic à long terme des patients. Compte tenu de l'incidence croissante des carcinomes cutanés, qui représentent les cancers les plus fréquents au monde et un motif de consultation quotidien (Dermatologie, 2022, Item 302), une stratégie de surveillance rigoureuse est impérative. Cette démarche s'inscrit dans une perspective de prévention secondaire, reconnaissant le CBC non seulement comme une entité pathologique à traiter, mais également comme un marqueur de risque significatif pour le développement d'autres néoplasies cutanées (Dermatologie, 2022, Item 302).

I. Objectifs de la surveillance post-thérapeutique

La surveillance du patient traité pour un CBC repose sur plusieurs objectifs distincts et complémentaires, essentiels pour une prise en charge optimale et durable (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5) :

A. Détection précoce des récidives locales

Le risque de récidive locale est une préoccupation majeure après le traitement d'un CBC, avec un risque global évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3). Une détection précoce permet une intervention rapide, souvent moins invasive, et prévient l'extension locorégionale à bas bruit qui peut compliquer la prise en charge ultérieure (Dermatologie, 2022, Item 302).

B. Dépistage des nouveaux carcinomes cutanés et mélanomes

Les patients ayant développé un CBC présentent un sur-risque significatif de développer d'autres carcinomes cutanés, qu'ils soient basocellulaires ou épidermoïdes, ainsi que des mélanomes, de manière synchrone ou métachrone (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5, QRM57). Ce lien épidémiologique fort fait du CBC un marqueur de risque de cancer de la peau, justifiant une surveillance et un dépistage actifs (Dermatologie, 2022, Item 302). L'examen clinique doit donc être exhaustif et porter sur l'intégralité du tégument (Dermatologie, 2022, QRM57).

C. Évaluation de l'efficacité des mesures de photoprotection

La survenue des carcinomes cutanés est fortement liée à l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV), avec une latence pouvant atteindre 30 à 40 ans entre l'exposition et l'apparition des lésions (Dermatologie, 2022, Item 302). La surveillance permet d'évaluer l'adhésion du patient aux mesures de photoprotection et de renforcer l'éducation thérapeutique à cet égard (Dermatologie, 2022, QRM57).

D. Éducation thérapeutique continue du patient

Le suivi est une opportunité continue d'informer le patient sur sa pathologie, les facteurs de risque, l'importance de l'auto-examen cutané et les signes d'alerte nécessitant une consultation rapide. Cette éducation est cruciale pour l'autonomisation du patient dans la gestion de sa santé cutanée.

II. Facteurs déterminant la stratégie de surveillance

La fréquence et l'intensité de la surveillance doivent être individualisées, en fonction des facteurs de risque liés à la tumeur initiale et aux caractéristiques propres du patient (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5).

A. Facteurs liés au carcinome basocellulaire initial (Facteurs de mauvais pronostic)

Certaines caractéristiques du CBC initial sont reconnues comme des facteurs de mauvais pronostic, augmentant le risque de récidive locale et influençant la stratégie de surveillance (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3) :

- **Localisation anatomique :** Les CBC situés à l'extrémité céphalique, notamment au niveau du nez et des zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont associés à un risque de récidive plus élevé en raison de la complexité anatomique et de la difficulté d'obtenir des marges saines.
- **Type histologique :** Les formes histologiques mal limitées, telles que le CBC sclérodermiforme (cf. section "Classification histologique") ou infiltrant, sont considérées comme plus agressives et plus difficiles à éradiquer complètement. Le CBC sclérodermiforme, par exemple, se présente cliniquement comme une cicatrice blanchâtre, rigide et mal limitée (Dermatologie, 2022, Fig. 20.9, Item 302).
- **Taille de la lésion :** Un diamètre tumoral élevé, en particulier supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur les zones à risque (nez et zones péri-orificielles), est un facteur de risque de récidive.
- **Caractère récidivant :** Un antécédent de récidive d'un CBC au même site augmente significativement le risque de récidives ultérieures.
- **Marge d'exérèse initiale :** Bien que non explicitement listé comme un facteur de mauvais pronostic dans l'encadré 20.3, une exérèse chirurgicale avec des marges insuffisantes (cf. section "Traitement chirurgical") est un facteur de risque majeur de récidive locale, nécessitant une surveillance accrue.

B. Facteurs liés au patient (Facteurs de risque individuels)

Les caractéristiques du patient jouent un rôle prépondérant dans l'évaluation du risque de développer de nouvelles lésions et doivent guider l'intensité de la surveillance (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5) :

• **Antécédents personnels de carcinomes cutanés multiples :** Un patient ayant déjà présenté plusieurs CBC ou d'autres cancers cutanés est à très haut risque de développer de nouvelles lésions (Dermatologie, 2022, QRM57).

• **Phototype cutané :** Les sujets à phototype clair sont particulièrement prédisposés aux carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, Item 302, QRM56).

• **Exposition solaire :** Une histoire d'exposition solaire chronique et/ou d'expositions intermittentes aiguës, notamment pendant l'enfance et l'adolescence, est un facteur de risque majeur (Dermatologie, 2022, Item 302, QRM56). L'héliodermie (cf. section "Épidémiologie et physiopathologie") est un signe clinique d'exposition solaire chronique.

• **Immunodépression :** Les patients immunodéprimés, notamment les greffés d'organes, présentent un risque considérablement accru de développer des carcinomes cutanés, en particulier des carcinomes épidermoïdes (Dermatologie, 2022, Item 302, QRM56, QRM57, Vignette 302-1). Certains traitements immunosuppresseurs, comme la ciclosporine, sont associés à un risque de cancers cutanés (Dermatologie, 2022, Tableau 7.2).

• **Syndromes génétiques prédisposants :** Des affections rares telles que le syndrome de Gorlin (naevomatose basocellulaire) ou le Xeroderma Pigmentosum confèrent une prédisposition génétique significative au développement de multiples CBC dès le jeune âge (Dermatologie, 2022, Item 302).

• **Antécédents de photothérapie :** Une exposition cumulée importante à la photothérapie (notamment la PUVAthérapie) est associée à un risque accru de cancers cutanés tardifs, principalement des carcinomes (Dermatologie, 2022, Tableau 7.1).

• **Âge :** La survenue des CBC est plus fréquente après 50 ans, et l'incidence augmente avec l'allongement de la durée de vie (Dermatologie, 2022, Item 302).

III. Modalités de la surveillance clinique

La surveillance du CBC est principalement clinique et doit être menée de manière régulière et prolongée.

A. Fréquence et durée de la surveillance

La surveillance clinique doit être "régulière selon le groupe pronostique et les facteurs de risque, au mieux à vie" (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5). Il n'existe pas de consensus universel sur un calendrier fixe, mais les recommandations générales suggèrent :

• **Patients à faible risque :** Examen clinique annuel après la première année de suivi.

• **Patients à risque intermédiaire :** Examen clinique tous les 6 à 12 mois pendant les 2 à 5 premières années, puis annuel.

• **Patients à haut risque :** Examen clinique tous les 3 à 6 mois pendant les 2 à 5 premières années, puis tous les 6 mois ou annuellement selon l'évolution.

Cette fréquence est ajustée en fonction de l'apparition de nouvelles lésions ou de l'évolution des facteurs de risque.

B. Examen clinique

L'examen clinique doit être systématique et exhaustif (Dermatologie, 2022, QRM57) :

- **Examen cutané complet :** Le patient doit être examiné sur la totalité du tégument, de la tête aux pieds, y compris les zones habituellement non exposées au soleil. Cette inspection minutieuse vise à détecter toute nouvelle lésion suspecte de CBC, de carcinome épidermoïde ou de mélanome (Dermatologie, 2022, QRM57).
- **Site de la lésion initiale :** Une attention particulière doit être portée à la cicatrice post-opératoire ou à la zone traitée pour rechercher des signes de récidive locale. Ces signes peuvent être subtils, tels qu'une induration, une modification de couleur, une érosion persistante ou l'apparition de petites perles translucides en périphérie (cf. section "Diagnostic clinique du CBC").
- **Palpation des aires ganglionnaires :** Bien que les métastases ganglionnaires du CBC soient exceptionnelles (Dermatologie, 2022, Item 302), la palpation des aires ganglionnaires régionales est un principe général de la surveillance des cancers cutanés, notamment en raison du risque de développement concomitant de carcinomes épidermoïdes ou de mélanomes, qui ont un potentiel métastatique plus élevé.
- **Dermoscopie :** L'utilisation de la dermoscopie est recommandée pour l'examen des lésions pigmentées ou suspectes, afin d'améliorer la précision diagnostique et de différencier les lésions bénignes des malignes.

C. Examens complémentaires

Pour le CBC, le bilan d'extension à distance n'est pas systématiquement indiqué, car les métastases sont exceptionnelles (Dermatologie, 2022, Item 302).

- **Bilan d'extension systématique :** "Le seul bilan d'extension systématique est l'examen clinique à la recherche d'autres carcinomes associés" (Dermatologie, 2022, Item 302).
- **Imagerie locale :** Dans les cas de CBC étendus ou infiltrants, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour évaluer l'extension tumorale et guider le traitement initial, mais elle n'est pas utilisée de manière routinière pour la surveillance post-thérapeutique des formes habituelles (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3).
- **Biopsie/Exérèse :** Toute nouvelle lésion suspecte ou toute modification d'une lésion existante doit faire l'objet d'une biopsie ou d'une exérèse à visée diagnostique et anatomopathologique pour confirmer le diagnostic et orienter la prise en charge (Dermatologie, 2022, Item 302).

IV. Prévention secondaire et éducation thérapeutique

L'éducation du patient est une composante essentielle de la surveillance, visant à réduire le risque de nouvelles lésions et à favoriser leur détection précoce.

A. Photoprotection

La réduction des expositions solaires est la mesure préventive la plus importante (Dermatologie, 2022, Tableau 20.5). L'éducation à la photoprotection doit être systématique et approfondie (Dermatologie, 2022, QRM57) :

- **Évitement des heures de fort ensoleillement :** Conseiller d'éviter l'exposition solaire entre 12h et 16h, lorsque l'intensité des UV est maximale.
- **Vêtements protecteurs :** Encourager le port de vêtements couvrants, de chapeaux à larges bords et de lunettes de soleil.
- **Crèmes solaires :** Recommander l'utilisation régulière et généreuse de crèmes solaires à large spectre (UVA et UVB) avec un indice de protection solaire (SPF) élevé (au moins 30-50+), à renouveler toutes les deux heures et après chaque baignade ou transpiration excessive.
- **Évitement des cabines de bronzage :** Insister sur l'interdiction formelle des cabines de bronzage, sources d'UV artificiels.
- **Rappel de la latence :** Expliquer que les effets des UV sur la peau peuvent se manifester des décennies après l'exposition (latence de 30-40 ans) (Dermatologie, 2022, Item 302), soulignant l'importance d'une photoprotection continue.

B. Auto-examen cutané

Le patient doit être formé à l'auto-examen cutané régulier, idéalement mensuel. Il doit apprendre à reconnaître les signes d'alerte :

- Toute nouvelle lésion cutanée persistante, qui ne guérit pas.
- Toute modification de taille, de forme, de couleur ou de texture d'une lésion existante.
- L'apparition d'une ulcération, d'un saignement ou d'une démangeaison persistante sur une lésion.

L'utilisation de miroirs ou l'aide d'un proche peut être nécessaire pour examiner les zones difficiles d'accès.

V. Cas particuliers

Certaines populations de patients nécessitent une approche de surveillance adaptée et souvent plus intensive.

A. Patients immunodéprimés

Les patients sous immunosuppresseurs, tels que les greffés d'organes, présentent un risque considérablement accru de développer des carcinomes cutanés, en particulier des carcinomes épidermoïdes qui peuvent être plus agressifs dans ce contexte (Dermatologie, 2022, Item 302, QRM56, QRM57, Vignette 302-1). La surveillance doit être plus

rapprochée, avec des examens cliniques fréquents (tous les 3 à 6 mois), et une collaboration étroite avec les équipes de transplantation ou d'immunologie est essentielle pour optimiser la gestion des traitements immunosuppresseurs et la prévention des cancers cutanés.

B. Syndromes génétiques prédisposants

Les patients atteints de syndromes génétiques comme le syndrome de Gorlin ou le Xeroderma Pigmentosum (Dermatologie, 2022, Item 302) nécessitent une surveillance dermatologique spécialisée et souvent multidisciplinaire, débutant dès l'enfance. Ces patients développent de multiples CBC et autres cancers cutanés, et leur prise en charge doit intégrer des stratégies de prévention et de dépistage très précoces et régulières.

En conclusion, la surveillance du carcinome basocellulaire est un processus dynamique, individualisé et prolongé, essentiel pour la détection précoce des récidives et des nouvelles lésions. Elle repose sur un examen clinique rigoureux, une évaluation continue des facteurs de risque et une éducation thérapeutique approfondie du patient aux mesures de photoprotection et à l'auto-examen cutané. Cette approche holistique est la pierre angulaire d'une prise en charge dermatologique oncologique de qualité, visant à améliorer la qualité de vie et le pronostic à long terme des patients.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Le carcinome basocellulaire (CBC) est le cancer cutané le plus fréquent, avec une incidence en constante augmentation, dépassant les 150 cas pour 100 000 habitants par an en France (Dermatologie, 2022). Bien que son diagnostic soit souvent clinique, certaines présentations morphologiques, des contextes étiologiques spécifiques ou des localisations anatomiques particulières peuvent rendre son identification plus complexe et influencer sa prise en charge. Cette section détaillera les cas particuliers et les situations spéciales du CBC, essentiels pour une approche diagnostique et thérapeutique rigoureuse au niveau du Diplôme d'Études Spécialisées (DES).

I. Variantes Clinico-Histologiques Particulières

Le CBC se manifeste sous diverses formes, dont certaines présentent des caractéristiques cliniques et histologiques distinctes, influençant le diagnostic différentiel et parfois le pronostic local.

I.A. Carcinome Basocellulaire Superficiel (ou Pagétoïde)

Cette variante est caractérisée par une croissance horizontale, souvent multifocale, au sein de l'épiderme et du derme papillaire. Cliniquement, il se présente comme une plaque érythémateuse, squameuse, parfois légèrement croûteuse, dont les bords sont perlés et surélevés (Dermatologie, 2022, Fig. 20.8). Sa ressemblance avec d'autres dermatoses inflammatoires peut rendre le diagnostic initial difficile.

Le diagnostic différentiel du CBC superficiel inclut des affections courantes telles que le psoriasis ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022). Une biopsie cutanée est souvent nécessaire pour confirmer le diagnostic et exclure ces affections. Histologiquement, les lobules de petites kératinocytes basophiles, caractéristiques du CBC, sont ici localisés principalement dans le derme superficiel et peuvent s'étendre de manière pagétoïde dans l'épiderme, rappelant la couche basale de l'épiderme (Dermatologie, 2022).

I.B. Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme (ou Morphéiforme)

Cette forme est réputée pour sa malignité locale insidieuse et ses limites cliniques imprécises, rendant son exérèse complète plus difficile. Cliniquement, il se manifeste comme une plaque indurée, blanchâtre ou jaunâtre, atrophique, souvent mal délimitée, pouvant ressembler à une cicatrice ou à une lésion de morphée (Dermatologie, 2022, Fig. 20.9). Les télangiectasies peuvent être absentes ou discrètes, ce qui complique davantage le diagnostic clinique.

Histologiquement, les formes sclérodermiformes sont associées à un stroma dense et fibreux qui entoure et comprime les travées tumorales, rendant les limites histologiques

imprécises et expliquant la difficulté d'obtenir des marges saines lors de l'exérèse chirurgicale (Dermatologie, 2022). Cette caractéristique histologique est un facteur de mauvais pronostic local, notamment en raison du risque élevé de récidive (Dermatologie, 2022).

I.C. Carcinome Basocellulaire Ulcéro-Végétant

Cette variante est généralement associée à des tumeurs de grande taille ou à une évolution prolongée et négligée. Cliniquement, il se présente comme une lésion ulcérée, souvent recouverte de croûtes hémorragiques, avec des bords surélevés et un aspect végétant ou bourgeonnant (Dermatologie, 2022, Fig. 20.10). L'ulcération peut être profonde et destructrice, entraînant une atteinte des tissus sous-jacents, notamment sur les zones à risque.

Bien que le CBC métastase exceptionnellement, cette forme peut entraîner une extension locorégionale significative et une destruction tissulaire locale importante, nécessitant une prise en charge agressive (Dermatologie, 2022).

I.D. Carcinome Basocellulaire Pigmenté (ou "Tatoué")

Le CBC pigmenté est une variante fréquente qui, bien que non illustrée spécifiquement dans les figures fournies, est cliniquement pertinente. Il présente une pigmentation mélanique, allant du brun clair au noir, pouvant simuler un mélanome (Dermatologie, 2022). La présence de perles translucides et de télangiectasies, caractéristiques du CBC nodulaire, reste un indice diagnostique important.

Le principal diagnostic différentiel est le mélanome, d'où l'appellation "CBC tatoués" (Dermatologie, 2022). La dermoscopie est un outil précieux pour distinguer ces lésions, révélant des critères spécifiques au CBC pigmenté (par exemple, des nids ovoides gris-bleu, des structures en feuille d'érable, des télangiectasies arborescentes). Cependant, l'examen anatomopathologique reste la référence pour une confirmation diagnostique définitive.

II. Situations Cliniques Spéciales

Certains contextes cliniques ou caractéristiques du patient confèrent au CBC un profil particulier en termes d'épidémiologie, de présentation ou de pronostic.

II.A. Carcinome Basocellulaire chez le Sujet Jeune

Bien que l'âge d'apparition du CBC soit généralement supérieur à 40 ans, des cas peuvent survenir chez des sujets plus jeunes, ce qui constitue une situation spéciale nécessitant une attention particulière (Dermatologie, 2022). Chez ces patients, il convient de rechercher des facteurs de risque spécifiques tels que des expositions solaires intenses et

intermittentes (coups de soleil) (Dermatologie, 2022), des antécédents familiaux de cancers cutanés, ou des prédispositions génétiques (cf. section II.B).

Il a été décrit que les CBC chez les jeunes adultes peuvent parfois présenter une croissance plus agressive (Leffell et al., 1991). Cette observation souligne l'importance d'une vigilance accrue, d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge rapide et adéquate dans cette population. Des études ont également mis en évidence des différences dans la distribution par âge et par site des sous-types histologiques de CBC, suggérant des étiologies distinctes (McCormack et al., 1997; Bastiaens et al., 1998).

II.B. Génodermatoses Prédisposantes

Plusieurs syndromes génétiques augmentent considérablement le risque de développer des CBC, souvent multiples et précoces, justifiant une surveillance dermatologique spécialisée et régulière.

- **Xeroderma Pigmentosum:** Cette affection autosomique récessive est due à une anomalie des gènes de réparation de l'ADN, rendant les patients extrêmement sensibles aux rayons ultraviolets (UV) et prédisposés à de multiples cancers cutanés, y compris les CBC, dès l'enfance (Dermatologie, 2022). La latence entre l'exposition aux UV et l'apparition des cancers cutanés est considérablement réduite chez ces individus.
- **Naevomatose Basocellulaire (Syndrome de Gorlin):** Ce syndrome autosomique dominant est lié à une anomalie du gène *PATCH* (PTCH1), un gène suppresseur de tumeur impliqué dans la voie de signalisation Hedgehog (Dermatologie, 2022). Il se caractérise par le développement de multiples CBC, souvent dès l'adolescence, associés à d'autres anomalies systémiques telles que des kystes odontogènes, des anomalies squelettiques (côtes bifides, scoliose), des calcifications de la faux du cerveau et un risque accru de médulloblastomes.
- **Épidermodysplasie Verruciforme:** Bien que principalement associée aux carcinomes épidermoïdes (CE), cette génodermatose rare, caractérisée par une susceptibilité anormale à certains papillomavirus humains (HPV), peut également prédisposer à des CBC (Dermatologie, 2022).

II.C. Immunodépression Acquise

L'immunosuppression est un facteur de risque majeur pour les cancers cutanés non mélaniques, y compris les CBC, qui peuvent être plus agressifs, plus nombreux et récidiver plus fréquemment dans ce contexte.

Les causes les plus fréquentes d'immunosuppression sont iatrogènes, notamment chez les receveurs de transplantation d'organes solides (TOS) (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023). D'autres situations incluent les maladies hématologiques chroniques (leucémie lymphoïde chronique, lymphome) et l'infection par le VIH (Dermatologie, 2022). Chez les patients transplantés d'organes, le risque de développer des carcinomes cutanés est considérablement augmenté, et ces tumeurs peuvent présenter un comportement plus

agressif. Une surveillance cutanée régulière et un dépistage précoce sont impératifs dans cette population à haut risque.

II.D. Localisations à Risque et Facteurs de Mauvais Pronostic Local

Certaines localisations anatomiques et caractéristiques tumorales sont associées à un risque accru de récidive locale ou d'extension locorégionale, nécessitant une prise en charge plus attentive.

- **Localisation:** L'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), est considérée comme une localisation à haut risque (Dermatologie, 2022). Ces zones sont soumises à une exposition solaire intense et présentent des structures anatomiques complexes rendant l'exérèse chirurgicale plus délicate et potentiellement mutilante.
- **Caractéristiques tumorales:** Les formes mal limitées, telles que le CBC sclérodermiforme (cf. section I.B) ou infiltrant, ainsi que les diamètres élevés (> 2 cm en général, ou > 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles), sont des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022). Le caractère récidivant d'un CBC, avec un risque global de récidive évalué entre 5 et 10%, est également un facteur de risque de mauvais pronostic local (Dermatologie, 2022).

Pour les formes étendues ou localisées dans ces zones à risque, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour évaluer l'extension profonde et guider le traitement (Dermatologie, 2022).

III. Diagnostic Différentiel des Formes Atypiques

Le diagnostic différentiel du CBC est large et varie en fonction de sa présentation clinique, nécessitant parfois des investigations complémentaires.

- **CBC superficiel:** Comme mentionné précédemment, il peut être confondu avec le psoriasis ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022).
- **CBC pigmenté:** Le mélanome est le principal diagnostic différentiel, d'où l'importance de la dermoscopie et, si nécessaire, de l'histopathologie (Dermatologie, 2022).
- **CBC sclérodermiforme:** Il peut être confondu avec une cicatrice, une morphée, ou un carcinome épidermoïde desmoplastique (Dermatologie, 2022).
- **Général:** D'autres tumeurs cutanées, y compris le carcinome épidermoïde (CEC) et la maladie de Bowen, doivent être considérées (Dermatologie, 2022).

En cas de doute diagnostique, notamment pour les formes atypiques ou les localisations complexes (comme la pointe du nez), une biopsie est fortement recommandée avant tout traitement définitif (Dermatologie, 2022, Cas clinique 20). L'examen anatomopathologique est essentiel pour confirmer le diagnostic et caractériser la forme histologique, ce qui est crucial pour la planification thérapeutique.

IV. Prise en Charge Spécifique et Surveillance

La gestion des CBC dans ces situations spéciales nécessite une approche adaptée, souvent multidisciplinaire.

• **Imagerie:** Pour les CBC présentant des facteurs de mauvais pronostic (cf. section II.D), une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être indiquée pour évaluer l'extension tumorale, notamment en profondeur, et guider la chirurgie (Dermatologie, 2022).

• **Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP):** La discussion en RCP est recommandée pour les CBC avec des critères agressifs, afin de valider la stratégie thérapeutique optimale, qui peut inclure la chirurgie de Mohs, la radiothérapie ou des traitements systémiques dans les cas avancés (Dermatologie, 2022).

• **Surveillance:** Le CBC est un marqueur de risque de développer d'autres cancers cutanés, y compris des mélanomes et des carcinomes épidermoïdes (Dermatologie, 2022). Une surveillance clinique régulière et à vie est donc indispensable, particulièrement chez les patients présentant des facteurs de risque (immunodépression, génodermatoses) ou des antécédents de CBC multiples ou agressifs (Dermatologie, 2022). Cette surveillance vise à détecter les récidives locales, l'extension locorégionale à bas bruit et la survenue de nouvelles tumeurs cutanées (Dermatologie, 2022). Le seul bilan d'extension systématique est l'examen clinique à la recherche d'autres carcinomes associés (Dermatologie, 2022).

• **Prévention:** La réduction des expositions solaires reste la mesure préventive fondamentale, commune aux CBC, CE et mélanomes, et doit être systématiquement conseillée à tous les patients, en particulier ceux à risque (Dermatologie, 2022).

Bibliographie

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• Lewis et al. - 2024 - Final analysis of phase II results with cemiplimab in metastatic basal cell carcinoma after hedgehog

• Gauci et al. - 2022 - Diagnosis and treatment of Merkel cell carcinoma European consensus-based interdisciplinary guideli

• Alam et al. - 2018 - Guidelines of care for the management of cutaneous squamous cell carcinoma

• cutaneous_melanoma

• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Peris et al. - 2019 - Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma European consensus–based interdisciplinary guidelin

• D'Angelo et al. - 2024 - Biomarker Analyses Investigating Disease Biology and Associations with Outcomes in the JAVELIN Merke

• nmsc

• dermatology handbook compressed-compressed

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• mcc

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma